

Recomendaciones para la preparación y cuidados del paciente

Tratamiento con DyeVL en plataforma Harmony

Indicaciones

Rosácea y cuperosis.
Lesiones vasculares (telangiectasias en rostro).
Malformaciones y tumores vasculares cutáneos benignos (mancha de vino oporto, hemangiomas, etc.).
Componente vascular en estrías rubras y cicatrices recientes.
Fotodaño, componente pigmentario y vascular.
Lesiones pigmentarias benignas epidérmicas en rostro (precaución melasma), escote y dorso de manos.

Materiales e insumos

Tratamiento

Lentes ciego pacientes (entregados con el equipo).
Lentes operador level 3 o level 5 (entregados con el equipo).
Vinchas o cofia.
Cinta hipoalérgica blanca (enmascarar cejas y línea de implantación).
Lápiz delineador blanco (marcación y/o enmascaramiento).
Gel de ultrasonido neutro.
Baja lengua y/o espátula.
Gasas y/o algodón.
Agua micelar o toallas desmaquillantes.
Papel para secar.
Guantes descartables.

Cuidado posterior

Gel descongestivo (post-tratamiento opcional).
Crema hidratante y/o humectante.
Protector solar FPS 50+.
Hidrocortisona 1[%] tópico (ej. Microsona, solo en caso de reacción aguda).
Antihistamínico (ej. Loratadina, solo en caso de reacción aguda).

Limpieza y desinfección del cabezal

Paño suave o papel.
Alcohol etílico al 70[%] (desinfección del cabezal).

Precauciones

- El tratamiento se recomienda para pacientes de fototipo I a IV.
- Evitar realizar el tratamiento en pieles bronceadas.
- El paciente deberá evitar la exposición solar previa y posterior al tratamiento por al menos 48[hs].
- No realice tratamientos con luz AFT sobre inyectables (rellenos o toxina botulínica) durante dos semanas posteriores a su aplicación.
- Indique profilaxis anti-herpética desde un día antes del tratamiento y hasta dos o tres días luego del tratamiento en caso de antecedentes de herpes simple en la zona de tratamiento.
- Nunca trabajar en la cercanía de tatuajes. Asegurarse de que el paciente no tenga ojos, cejas o labios delineados de forma permanente, si es así, enmascarar adecuadamente.

Preparación del paciente

- En pieles hiperqueratósicas o engrosadas es recomendable realizar un peeling o exfoliación previo a la sesión con el fin de eliminar el estrato corneo y permitir que la luz penetre correctamente en la piel.
- Puede optarse por un tratamiento local previo a la sesión de luz AFT con ácido glicólico y retinoico en bajo porcentaje por la noche, 15 días antes de la sesión, para preparar la piel.
- Un pre-tratamiento con tópicos despigmentantes (hidroquinona) y/o rutina domiciliaria para pacientes con fototipos de III y IV o pieles con fotodaño severo, puede ser útil para reducir el riesgo potencial de efectos adversos e hiperpigmentación.
- Indicar siempre una hidratación y humectación diaria adecuada de la piel con adecuada fotoprotección.

Tratamiento

- Indicar al paciente que evite maquillaje denso para concurrir al consultorio.
- Colocar cofia y/o vincha al paciente. Enmascarar cejas, línea de implantación, nevus y tatuajes según corresponda.
- Limpiar la piel con un producto no alcohólico removiendo maquillaje, lociones y/o cremas en la zona de tratamiento. Retirar todos los accesorios como aros, colgantes, etc.
- Si corresponde, con lápiz delineador blanco delimitar el área o lesiones a tratar.
- Colocar lentes ciegos de protección al paciente. Utilizar lentes operador según corresponda.
- Colocar una capa de gel neutro de ultrasonido de aproximadamente 0,5[cm] de forma homogénea en la zona a tratar. En caso de un tratamiento *in motion* la cantidad de gel puede ser menor.
- Definir los parámetros según corresponda en función de la indicación, características de la piel/lesión y el protocolo recomendado. Fluencia y ancho de pulso para la técnica estacionaria. Fluencia y ciclo de emisión para la técnica *in motion*.
- Realizar el tratamiento estacionario o *in motion* desplazándose sobre la piel según corresponda.
- Retirar el gel de ultrasonido neutro con una espátula.
- Realizar tratamiento descongestivo inmediatamente después (opcional).
- Colocar crema hidratante o humectante y protector solar.
- El enrojecimiento y leve edema es normal.
- Las lesiones vasculares de menor calibre tienden a colapsar. En otros casos, cuando existe mayor presencia de hemoglobina, los vasos se oscurecerán.
- Las lesiones pigmentarias pueden oscurecerse inmediatamente luego del tratamiento. Esto indica una correcta absorción de la luz, lo que desencadenará posteriormente en su eliminación.
- Indicarle al paciente los cuidados a seguir los días posteriores al tratamiento.

Evolución

Luego de la sesión el paciente sentirá un ardor que desaparecerá en el transcurso de aproximadamente 2 o 3 horas. La piel se verá eritematosa y edematosa hasta por 48 horas. En el caso de tratamientos agresivos podrían formarse costras sobre la lesión las cuales caerán luego de 10 a 15 días, periodo en el que la piel debe mantener debidamente hidratada, humectada y protegida del sol. Dependiendo de la agresividad del tratamiento el periodo de inactividad puede ser nulo o de 12 a 24 horas.

Cuidados posteriores para el paciente

- La sensación aguda de ardor e incomodidad disminuirá luego de 2 o 3 horas. Pueden aplicarse máscaras o geles descongestivos.
- Dependiendo de los parámetros seleccionados para el tratamiento el paciente podrá sentir una sensación normal de calor, acompañado de eritema y edema, durante 24 a 48 horas.
- Evitar fuentes de calor (calefacción, agua caliente, ceras depilatorias, ventanas del automóvil, etc.) que pudiera aumentar la temperatura de la piel, ya que se incrementará el enrojecimiento e incomodidad.
- La limpieza suave e hidratación o humectación intensa debe realizarse al menos dos veces al día. El uso de los ácidos tópicos debe ser suspendido por al menos 10 días.
- Los tratamientos agresivos para el tratamiento de rosácea pueden generar hinchazón de los párpados. Se sugiere dormir con dos almohadas al menos las dos primeras noches para evitarla. Si por la mañana existe hinchazón puede realizarse un drenaje linfático manual del rostro.
- Las posibles costras oscuras que suelen formarse después del tratamiento no deberán ser removidas. Caerán naturalmente entre los 10 y 15 días posteriores a la sesión, de lo contrario podrían generarse cicatrices.
- La zona tratada debe ser protegida de la luz solar y artificial. Indicar fotoprotección (FPS 50+) para evitar la pigmentación posterior, renovando la aplicación cada dos horas. Se sugiere protector fluido sin color en el caso de que existan costras y protector compacto con color si no las hay o luego de que caigan.
- La siguiente sesión se realizará de acuerdo a la indicación profesional, teniendo como referencia la evolución, respuesta de la piel y parámetros utilizados en la sesión previa.
- El paciente deberá informar al profesional médico responsable del tratamiento si existe dolor, hinchazón excesiva, ampollas o cualquier otra respuesta no prevista.